



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO

Urgência, Emergência e UTI

PCR e suporte de vida · Classificação de risco · Choque — teoria
e bizus

Concurso de Enfermagem / Pernambuco · Cargo: Enfermeiro

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

Diretrizes conferidas · AHA 2025 · Protocolo de Manchester

O eixo que exige número exato

Urgência e emergência caem sempre — e aqui a banca cobra o número preciso: profundidade, frequência, relação. Errar um dígito é errar a questão.

Este ebook cobre a **parada cardiorrespiratória (PCR)** e o suporte de vida, a **classificação de risco** (Protocolo de Manchester) e o **choque**. Os números da reanimação foram conferidos nas diretrizes vigentes da American Heart Association (AHA).

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **PCR e RCP** — os números da reanimação de alta qualidade.
- ◆ **Ritmos** — chocáveis (FV/TVSP) × não chocáveis (AESP/assistolia).
- ◆ **Classificação de risco** — as cores de Manchester.
- ◆ **Choque** — os quatro tipos e seus sinais.

Nota de atualização

As diretrizes de RCP são revisadas periodicamente pela AHA/ILCOR. Os parâmetros aqui seguem a versão vigente. **Confirme a diretriz do ano no material oficial antes da prova** — a banca cobra o número exato de profundidade, frequência e doses.

Sumário

1 PCR e RCP de alta qualidade

Reconhecimento

Os números da compressão

Via aérea e ventilação

2 Ritmos e desfibrilação

Chocáveis × não chocáveis

O choque e as drogas

5H e 5T

3 Classificação de risco

Protocolo de Manchester

As cinco cores

4 Choque circulatório

Os quatro tipos

Sinais e conduta

5 Síntese e bízus finais

Quadro de revisão rápida

1

PCR e RCP

A reanimação de alta qualidade. Aqui, número é tudo.

1 · Reanimação de alta qualidade

A parada cardiorrespiratória (PCR) é reconhecida por: paciente **irresponsivo**, sem respiração normal (ou apenas *gaspings*) e **sem pulso** palpável — a checagem do pulso deve durar no máximo **10 segundos**. Reconhecida a PCR, inicia-se imediatamente a RCP.

Diretrizes AHA para RCP e ACE — 2025 (publicadas em outubro de 2025)

◆ Os números da compressão torácica

PARÂMETRO	VALOR
Frequência	100 a 120 compressões por minuto.
Profundidade	5 a 6 cm no adulto (mínimo 5, máximo 6).
Retorno do tórax	Permitir o retorno completo (recoil) a cada compressão.
Local	Metade inferior do esterno, região hipotenar das mãos.
Rodízio	Trocar o compressor a cada 2 minutos (ou antes, se fadiga).
Interrupções	Mínimas — pausas inferiores a 10 segundos.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que esses números — e não outros. A compressão é uma bomba artificial: ao comprimir, o sangue é expulso; ao permitir o **retorno completo (recoil)**, o coração se enche de novo. Se você não deixa o tórax voltar, comprime um coração *vazio* — e o débito despenca.

A profundidade tem teto: **abaixo de 5 cm** não gera fluxo suficiente; **acima de 6 cm** aumenta lesão sem ganho. A frequência também: acima de 120/min não há tempo de enchimento entre as compressões. E as **pausas** são o vilão silencioso — a pressão de perfusão coronariana cai a cada interrupção e leva vários segundos para se recuperar. Daí a meta de **fração de compressão ≥ 60%**: o paciente deve estar recebendo compressão na maior parte do atendimento.

BIZU ESTRATÉGICO

Memorize o núcleo: “**5 a 6, 100 a 120, 30:2**” — profundidade de 5 a 6 cm, frequência de 100 a 120/min, relação de 30 compressões para 2 ventilações. A cadência de 100–120 é a da música *Stayin' Alive*. Local: **metade inferior do esterno**, no centro do tórax.

COMO A BANCA COBRA

“Durante a RCP em adulto, sem via aérea avançada, o profissional deve realizar compressões com profundidade e frequência, respectivamente, de...”

5 a 6 cm e 100 a 120/min. A banca oferece “pelo menos 5 cm” sem teto (redação antiga) ou “no mínimo 100/min” sem limite superior — hoje há **faixa com teto** nos dois.

◆ Via aérea e ventilação

- ◆ **Sem via aérea avançada:** relação **30:2** (30 compressões para 2 ventilações).
- ◆ **Com via aérea avançada:** compressões **contínuas** e 1 ventilação a cada 6 segundos (cerca de 10/min), de forma assíncrona.

PEGADINHA CLÁSSICA

Erro grave e cobrado: **hiperventilar**. Ventilar acima do recomendado aumenta a pressão intratorácica, reduz o retorno venoso e piora a sobrevida. Mais ventilação não é melhor — é pior.

1 · O que mudou na AHA 2025

As Diretrizes de 2025 trouxeram mudanças pontuais, mas cobráveis. As principais:

ATUALIZAÇÕES DA AHA 2025

- ◆ **Cadeia de sobrevivência unificada** — adulto e pediátrico, intra e extra-hospitalar, num só fluxo.
- ◆ **OVACE (engasgo)**: o algoritmo mudou — agora **5 golpes nas costas + 5 compressões**, alternando (veja adiante).
- ◆ **Epinefrina precoce** nos ritmos **não chocáveis**: o mais rápido possível.
- ◆ **Via de escolha** para drogas: **intravenosa**; se indisponível, **intraóssea**. A via **endotraqueal NÃO é recomendada**.
- ◆ **Vasopressina** (isolada ou com adrenalina): **sem benefício** adicional.
- ◆ **Desfibrilação sequencial dupla** e mudança de vetor: **utilidade não comprovada** na FV/TV refratária.
- ◆ **Paciente obeso**: mesma técnica — **sem ajuste** de profundidade ou frequência.
- ◆ **Debriefing** após a PCR: reforçado como ferramenta de melhoria da equipe.

BIZU ESTRATÉGICO

Duas trocas novas que a banca vai explorar: (1) a via **endotraqueal** para drogas **não é recomendada** — é IV, e se não der, **intraóssea**; (2) **vasopressina não traz benefício** — a droga é a **adrenalina**. Alternativa que ressuscita a vasopressina ou a via endotraqueal está usando diretriz velha.

1 • OVACE — a mudança de 2025

A obstrução de via aérea por corpo estranho (o **engasgo**) teve o algoritmo **alterado** — e é a mudança mais concreta da AHA 2025.

SITUAÇÃO	CONDUTA
Obstrução LEVE (tosse eficaz)	Não interferir. Encorajar a tosse e observar.
Obstrução GRAVE — adulto e criança	5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões abdominais, alternando, até desobstruir ou a vítima perder a consciência.
Gestante no 3º trimestre e obeso	Substituir as compressões abdominais por compressões torácicas (metade inferior do esterno).
Bebê < 1 ano	5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas. Compressão abdominal é contraindicada (risco de lesão de órgãos).
Perda de consciência	Iniciar RCP. Inspeccionar a boca apenas antes das ventilações.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que mudou. Antes, o protocolo para adulto e criança começava direto com a **manobra de Heimlich** (compressões abdominais), e os golpes nas costas ficavam reservados aos bebês. Estudos observacionais mostraram **maior taxa de desobstrução e menos lesões** quando se começa pelos golpes nas costas.

Há também um ganho de ensino: agora o algoritmo é **o mesmo** para todas as idades (mudando só o tipo de compressão), o que reduz erro sob estresse — que é justamente quando o engasgo acontece.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas proibições: (1) a **varredura cega** da boca é **proibida** — só se remove o corpo estranho **se ele estiver visível**, porque a varredura empurra o objeto mais fundo; (2) na obstrução **leve**, com tosse eficaz, **não se intervém** — a tosse é o mecanismo mais eficaz que existe. Bater nas costas de quem está tossindo bem pode piorar.

COMO A BANCA COBRA

“Segundo as diretrizes vigentes, diante de adulto com obstrução grave de via aérea por corpo estranho, consciente, o socorrista deve iniciar com...”

5 golpes nas costas, seguidos de 5 compressões abdominais, alternando. A alternativa “iniciar imediatamente a manobra de Heimlich” era a correta na diretriz anterior — hoje está **desatualizada**.

2

Ritmos e drogas

Chocável ou não chocável? Essa decisão governa toda a conduta.

2 · Ritmos, choque e drogas

Assim que o desfibrilador chega, checka-se o ritmo. Toda a conduta diverge a partir daqui — os quatro ritmos de PCR se dividem em dois grupos:

GRUPO	RITMOS E CONDUTA
Chocáveis	Fibrilação ventricular (FV) e Taquicardia ventricular sem pulso (TVSP). Conduta: desfibrilação precoce.
Não chocáveis	Atividade elétrica sem pulso (AESP) e Assistolia. Conduta: RCP e adrenalina precoce; não se choca.

PEGADINHA CLÁSSICA

A pegadinha mais clássica de toda a urgência: **chocar assistolia ou AESP**. Esses ritmos **NÃO** se chocam — a conduta é RCP e adrenalina. Só **FV e TVSP** recebem choque. Marcar “desfibrilar assistolia” é erro que elimina candidato.

BIZU ESTRATÉGICO

Diferença que cai: **assistolia** = ausência total de atividade elétrica (linha reta). **AESP** = há ritmo elétrico organizado no monitor, mas *sem pulso*. Nos dois, o tratamento é o mesmo: RCP + adrenalina + tratar causas.

◆ As drogas da PCR

DROGA	USO E DOSE
Adrenalina (epinefrina)	1 mg a cada 3 a 5 minutos. Em ritmo não chocável, o mais precoce possível. Em chocável, após o 2º choque.
Amiodarona	Antiarrítmico de escolha na FV/TVSP refratária. 1ª dose 300 mg; 2ª dose 150 mg.
Lidocaína	Alternativa à amiodarona quando esta não está disponível.
Via de administração	Intravenosa é a de escolha. Sem acesso IV, intraóssea . A via endotraqueal NÃO é recomendada .
Vasopressina	Sem benefício adicional, isolada ou associada à adrenalina.

◆ Causas reversíveis — 5H e 5T

Especialmente nos ritmos não chocáveis, identificar e tratar a causa é o que determina o prognóstico. O mnemônico organiza a busca:

5H E 5T

- ◆ **5H:** Hipóxia, Hipovolemia, Hidrogênio (acidose), Hipo/hipercalcemia, Hipotermia.
- ◆ **5T:** Tensão no tórax (pneumotórax), Tamponamento cardíaco, Tóxicos, Trombose pulmonar, Trombose coronariana.

BIZU ESTRATÉGICO

Após o choque, **não** se checa ritmo nem pulso de imediato: retoma-se a RCP por 2 minutos e só então se reavalia. Querer conferir o pulso logo após o choque é erro de sequência que a banca adora cobrar.

3

Classificação de risco

Quem é atendido primeiro? Não é por ordem de chegada — é por gravidade.

3 · Protocolo de Manchester

O acolhimento com classificação de risco organiza o atendimento por **gravidade**, não por ordem de chegada. No Brasil, o protocolo mais usado é o **Sistema de Triagem de Manchester**, adotado a partir de 2008, que usa cinco cores.

COR	PRIORIDADE / TEMPO-ALVO
Vermelho	Emergência — atendimento imediato. Risco iminente à vida.
Laranja	Muito urgente — cerca de 10 minutos.
Amarelo	Urgente — em torno de 60 minutos.
Verde	Pouco urgente — pode aguardar (cerca de 120 minutos).
Azul	Não urgente — menor prioridade; pode ser encaminhado a outro serviço.

PEGADINHA CLÁSSICA

Os **tempos exatos variam** entre instituições (amarelo pode aparecer como 50 ou 60 min; verde como 90 ou 120). O que **não muda** é a ordem das cores: **vermelho = imediato** e **azul = menor prioridade**. Questão que inverte as cores é pegadinha; foque na ordem, não decore o minuto isolado.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que classificar por cor, e não por chegada. O pronto-socorro tem recurso finito e demanda infinita. Se o atendimento fosse por ordem de chegada, um infarto que chegou às 10h esperaria atrás de vinte resfriados que chegaram às 9h — e morreria na fila. A classificação de risco **inverte a lógica**: atende primeiro quem *não pode esperar*, não quem chegou antes.

É por isso que a triagem é **atividade do enfermeiro** e é feita em minutos: ela não diagnostica, ela **ordena**. E é também por isso que o paciente azul pode — e deve — ser reencaminhado à atenção básica: ele não precisa de emergência.

BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico da ordem (do mais grave ao mais leve): “**Vermelho Late Alto, Verde Azula**” — Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul. Vermelho sempre primeiro, azul sempre por último.

4

Choque circulatório

Quatro tipos, uma emergência. Reconhecer o tipo direciona a conduta.

4 · Os tipos de choque

Choque é a incapacidade do sistema circulatório de perfundir adequadamente os tecidos. Reconhecer o tipo é essencial, porque a conduta muda conforme a causa.

TIPO	CAUSA E CARACTERÍSTICA
Hipovolêmico	Perda de volume (hemorragia, desidratação). O mais comum. Conduta: reposição volêmica.
Cardiogênico	Falha de bomba (IAM extenso, arritmias). O coração não ejeta o suficiente.
Distributivo	Vasodilatação intensa. Inclui o séptico, o anafilático e o neurogênico.
Obstrutivo	Obstrução mecânica ao fluxo (tamponamento, pneumotórax hipertensivo, TEP).

BIZU ESTRATÉGICO

Sinais gerais de choque a reconhecer no enunciado: **taquicardia, hipotensão, pele fria e pegajosa, palidez, oligúria e alteração do nível de consciência**. Exceção útil: no choque **distributivo** inicial (séptico/neurogênico), a pele pode estar *quente* — detalhe que a banca explora.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a pele é fria no choque — e por que às vezes não é. Na maioria dos choques, o organismo detecta a queda de perfusão e responde com **vasoconstrição periférica**: fecha a circulação da pele e das extremidades para *centralizar* o sangue no cérebro e no coração. Daí a pele fria, pálida e pegajosa, e a oligúria (o rim também é sacrificado).

A exceção é o choque **distributivo** (séptico, neurogênico, anafilático): nele o problema é a vasodilatação — os vasos não conseguem fechar. Por isso, na fase inicial, a pele pode estar **quente e corada**, mesmo com o paciente chocando. É o “choque quente” — e é exatamente aí que se perde tempo achando que o paciente está bem.

PEGADINHA CLÁSSICA

O choque **hipovolêmico** é o mais comum e sua conduta inicial é **reposição de volume**. A banca oferece “vasopressor” como primeira conduta no hipovolêmico — errado: primeiro repõe-se volume; droga vasoativa não substitui o que falta.

5

Síntese

A página que blinda o eixo de urgência.

5 · Revisão rápida do eixo

PCR E RITMOS

- ◆ RCP: **5–6 cm, 100–120/min**, relação **30:2**.
- ◆ Com via aérea avançada: compressão contínua + 1 ventilação a cada 6 s.
- ◆ Chocáveis: **FV e TVSP**. Não chocáveis: **AESP e assistolia**.
- ◆ Adrenalina 1 mg a cada 3–5 min; amiodarona 300 mg (2ª dose 150 mg). Nos **não chocáveis, adrenalina precoce**.
- ◆ **AHA 2025**: via IV → intraóssea; **endotraqueal NÃO**. **Vasopressina sem benefício**. Obeso: mesma técnica.
- ◆ **OVACE (2025)**: **5 golpes nas costas + 5 compressões**, alternando. Bebê: compressão **torácica**. Varredura cega proibida.

CLASSIFICAÇÃO E CHOQUE

- ◆ Manchester: vermelho (imediate) → laranja → amarelo → verde → azul (menor prioridade).
- ◆ Atendimento por **gravidade**, não por ordem de chegada.
- ◆ Choques: hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, obstrutivo.
- ◆ Hipovolêmico é o mais comum; conduta inicial é **repor volume**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas que mais caem: (1) chocar assistolia/AESP; (2) checar pulso logo após o choque; (3) inverter as cores de Manchester; (4) vasopressor antes de volume no choque hipovolêmico; (5) iniciar o engasgo direto pelo Heimlich (a AHA 2025 começa pelos **golpes nas costas**); (6) usar a via **endotraqueal** para drogas. Domine essas seis e você blinda o eixo.

“Na urgência, a diferença entre acertar e errar é um número. Decore o número — e reconheça o ritmo.”

Parâmetros conferidos nas Diretrizes AHA para RCP e ACE de 2025 (publicadas em outubro de 2025). As diretrizes são revisadas periodicamente — confirme os números na versão do ano antes da prova.